

INDICADO POR: Clínica da Polissonografia

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ORLANDO SANTOS DA COSTA

IDADE: 28 PESO: 150 ALTURA: 1,81 PROFISSÃO: médica (residente - Otorrinolaringologia)

SINTOMAS: Roncos parciais, sonolência diurna e cansaço

QUEIXAS: Insônia de início de noite

MEDICAMENTOS: Floxeremina / Maltexona / Nealeptil / Losartana / Atenolol

MÉDICO:

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: sedentário

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 21 22h

HORA QUE DORME: 22 - 0h HORA QUE ACORDA: 6-7h

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N esta em tratamento há 1 semana

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 94cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 16,1cm SPO2: 86%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS Otitite crônica: 43%

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

27/05/25 Avaliação Localização Max. Yuhell (M)
Auto 4 - 12cmH₂O
Natasha

05/06/25 Pmed: 5.7cmH₂O
IAH = 1,1cm
m de ev: 7h23'
freq: 33,8 l/m
fixação P = 6cmH₂O
Pete relata que sentiu uma
pequena melhora na
sonolência
Natasha

24/06/25 $P = 6 \text{ cm H}_2\text{O}$

$$I_{AH} = 0,5 \text{ e/h}$$

medeuro: 6h 53'

freq. 36,91/m

Bem adaptado

8) quinquos

Natacha

Nome: ORLANDO SANTOS DA COSTA
Data de Nascimento: 27-12-1996
IMC: 43,34
Sexo: Masculino
Data do exame: 07-07-2024

Peso: 142 kg
Altura: 1,81 m
Médico: DR. ORLANDO SANTOS DA
COSTA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 509,3 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 236,0 e 75,5 minutos. O tempo total de sono foi de 223,0 min, eficiência de 43,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 55,8%; estágio N3: 20,4%; sono REM: 21,3%. O índice de despertares foi de 2,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 16,1/hora, sendo 12 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 47 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 86%, permanecendo 1,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 92 bpm e NREM de 49 - 87 bpm.

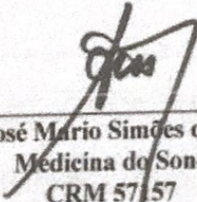
CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 16,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157